

HIV · diagnóstico, profilaxias e IRIS

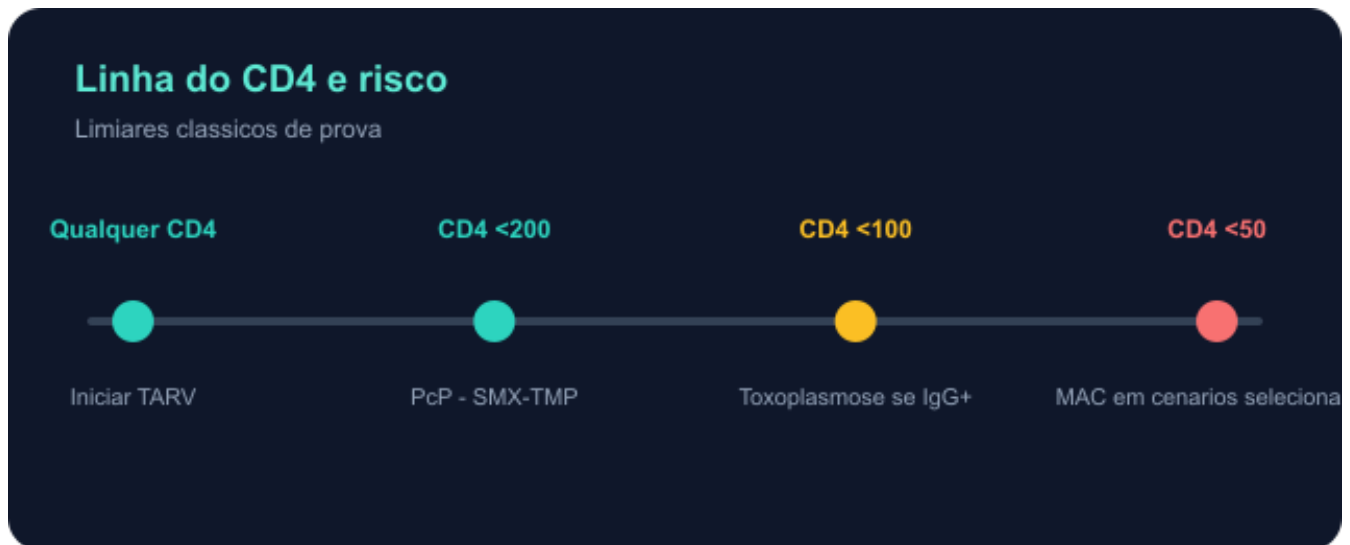
Todo paciente com HIV deve iniciar TARV o mais cedo possível. Use CD4 e clínica para decidir profilaxias e investigar oportunistas antes de atribuir tudo a 'efeito da medicação'.

Diagnóstico

Lembre - Diagnóstico

Triagem com teste rápido/4ª geração e confirmação conforme fluxo. Em infecção aguda, carga viral pode fechar diagnóstico quando sorologia ainda é negativa/indeterminada.

Memorize limiares: quanto menor o CD4, maior o espectro de oportunistas e necessidade de profilaxia.



Oportunistas high-yield

- PcP: dispneia + hipoxemia + LDH!; SMX-TMP ± corticoide se PaO₂ baixa
- Neurotoxoplasmose: múltiplas lesões anelares; tratar empírico se alta probabilidade
- Criptococose: cefaleia/meningite subaguda; latência de TARV após início do tratamento
- TB: sempre pensar; iniciar tratamento da TB e TARV com timing conforme meningite/CD4

Profilaxias clássicas

Condição | Profilaxia

PcP (CD4 <200) | SMX-TMP

Toxoplasmose (CD4 <100 + IgG+) | SMX-TMP

Exposição sexual de risco | PEP o mais cedo ("d72 h)

Parceiro sorodiscordante / risco contínuo | PrEP (seguir protocolo)

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

IRIS: piora paradoxal após início da TARV com recuperação imune. Não suspenda TARV rotineiramente — trate o oportunista e suporte; exceções raras (ex.: criptococose grave do SNC) seguem protocolo específico de timing.